

THRESHOLD

# THRESHOLD

---

**За восемь недель находит, какая еда  
вызывает симптомы — по клиническому  
протоколу, а не по советам.**

Первый протокол из библиотеки. Дальше —  
сон, давление, нагрузка.

# Протокол, который работает, существует. Проходить его некому

---

- 15–25 млн взрослых в США. Симптомы годами
- Гуглят, убирают наугад, бросают дневник
- Гайдлайн ACG: диета сложна, нужен подготовленный диетолог
- Диетологов на эту аудиторию не хватает
- Кто начал — застревает на элиминации

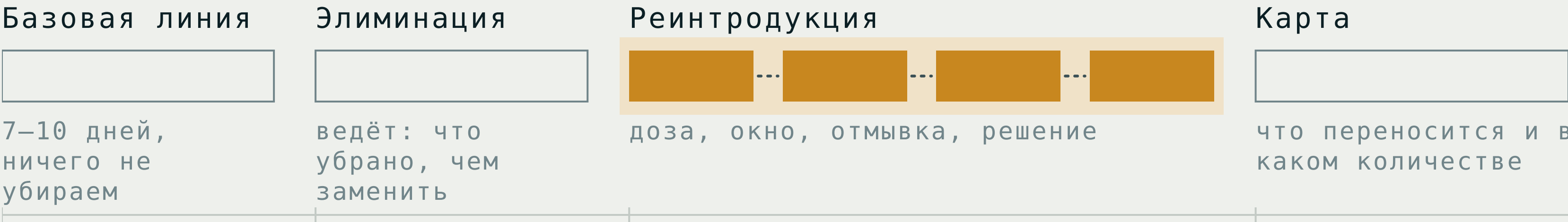
# Измерять стало бесплатно. Доводить до конца — нет

---

- OpenAI раздаёт медицинскую память
- Whoop бесплатно принимает любые анализы
- Все выпустили «протоколы» — это план, а не ведение
- Пользователи: данные лежат и ждут
- Их удержание держится на том, что открывать приятно

THRESHOLD

# Приложение знает, какой у вас сегодня день протокола



Правило перехода арифметическое. Протокол умеет закончиться выводом «не помогло».

# Два года назад это было нельзя построить. Через год позицию займут

---

- Разложить блюдо на группы стало дешевле
- Голосовой ввод дошёл до нужного качества
- Рынок приучен к ИИ в здоровье — не нами
- Позиция названа, но не занята



# Мы это уже построили. Соберём заново — по спецификации

---

- Команда несколько лет вместе. Система работает в клинике
- Пройдено: сбор из Apple Health, распознавание выписок, память фактов, журнал питания, корреляции
- Движок разворачивает протокол настройкой, а не разработкой
- Пересборка с нуля по функциональной спецификации. Юридическая проверка чистоты — до начала работ

THRESHOLD

**\$179 приносит \$155. Вопрос в том, дешевле ли \$63 привести человека**

---

**\$155**

ВКЛАД С ПРОГРАММЫ

**\$188**

ПОЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

**\$63**

ПОТОЛОК САС

- Вклад с программы — \$155 из \$179. Себестоимость \$11,89, резерв на возвраты 7%
- Пожизненная ценность — \$188 в базовом сценарии, \$249 в целевом
- Потолок САС при отраслевом требовании  $LTV/CAC \geq 3$ : **\$63-83**
- Рынок: 15–25 млн взрослых в США. Ограничение не в размере рынка, а в цене привлечения

# Протокол конечен. Продаём не подписку, а очередь протоколов

---

- Программа — \$179. Восемь недель, карта переносимости, выписка врачу
- Годовой план поддержания — \$149, оплата в момент завершения протокола
- Следующий протокол — снова программа, \$149
- Ключевая метрика: доля перешедших ко второму протоколу
- Позже — тариф со специалистом



# Каждый процентный пункт завершаемости стоит \$30 тысяч капитала

---

- Клиническая базовая линия: 41% доходят до шестой недели — исследование UCLH, 233 пациента, программа с диетологом
- Это приверженность **с** диетологом, но **без** ежедневной поддержки. Базовая линия «если ничего не делать»
- Цель — 51% завершивших протокол. Разница между базовым и целевым сценарием: **\$670k требуемого капитала**
- Хвост продаётся только дошедшим: годовой план, второй протокол, третий
- Это и есть продуктовая задача Threshold. Не «удобнее вести дневник», а «довести до конца»

---

41% — из одного исследования на 233 пациентах: Mari et al., Eur J Gastroenterol Hepatol, 2019, UCLH. Самоотчётная приверженность на конец шестинедельной программы, не отраслевая константа.

THRESHOLD

# Инструменты для записи есть. Очередь никто не ведёт

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| ИЗМЕРЯЮТ                   | Function, Whoop, Oura — план, а не ведение     |
| КУРС ИЛИ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ | Nerva; Monash — Step 2, дозы, лесенка          |
| ВЕДУТ                      | Salvo \$127/мес и Sleep Reset — на живых людях |
| ПРОГРАММНО                 | только Stellar Sleep, один протокол            |
| ПУСТО                      | несколько протоколов подряд в одной подписке   |

## THRESHOLD

# Не строим, пока не проверим, дешевле ли \$75 привести человека

- Лендинг с реальной оплатой. Две версии цены: \$179 разово против \$20/мес
- **Пороги по САС, объявлены заранее:**

|           |               |
|-----------|---------------|
| НИЖЕ \$75 | идём по плану |
|-----------|---------------|

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| \$75–150 | идём только с проработанным планом органики |
|----------|---------------------------------------------|

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ВЫШЕ \$150 | платный поиск не основной канал, второй этап не тратится на его масштабирование |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|

- Критерий чтения A/B: подписка выигрывает только при конверсии **втрое выше**. Двукратный прирост — всё ещё проигрыш по экономике
- 12 интервью проведены. Страница готова
- Дальше: 8 недель сборки, октябрь — стенд с платящими

# Четыре риска и механизм по каждому

РАССТРОЙСТВА  
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

В клинической когорте 23% с риском РПП, и приверженность диете у них **выше**, чем у остальных: 57% против 35%. Метрика роста и главный риск причинения вреда смотрят в одну сторону. Скрининг на входе, правило остановки внутри протокола, отказ обслуживать при срабатывании — в первой версии, не во второй

РЕГУЛЯТОРНЫЙ

Наблюдения, а не утверждения; разбор формулировок под FDA и FTC до включения трафика; юрист до релиза

ПЛАТЯТ ЛИ

Смоук-тест с порогами по САС до разработки

ЛИЦЕНЗИИ НА ШКАЛЫ

В первой версии собственные инструменты

# Покупатель платит за данные и канал, а не за выручку

---

- Фарма с гастроэнтерологическим портфелем — нужны дозозависимые данные по подгруппам FODMAP на тысячах людей
- Консолидаторы цифровой терапии в гастро — покупают возможность, которой у них нет: фазу реинтродукции
- Потребительское здоровье и питание, платформы льгот для работодателей
- Порядок сумм: при выручке \$1–3М с подтверждённым удержанием — \$5–20М. Стратегические покупатели платят на 25–40% больше финансовых
- Что делает компанию продаваемой: регулярная выручка, права на деперсонализированные данные в оферте с первого месяца, измеренный результат на когортах, независимость от основателей

---

Между кассой и мультипликатором есть противоречие: разовая программа лучше для денежного потока, регулярная подписка — для оценки при продаже. Решение принимается до запуска.



THRESHOLD

# \$165k, два этапа фиксированной ценой

## ЭТАП 1 — СМОУК-ТЕСТ, \$25 000

Лендинг с реальной оплатой, трафик, интервью, разбор формулировок под FDA/FTC, комплаенс предоплаты.

Ответ: дешевле ли \$75 привести платящего человека — с точностью, достаточной для решения.

## ЭТАП 2 — MVP, \$140 000, ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

Восемь недель. Полная сборка плюс оставшийся юридический пакет — юрлицо, товарный знак, страхование, IAP, согласия под My Health My Data.

Цена отражает, что здесь создаётся ядро — основная доля ценности контракта, а не пропорция от срока. Фиксированная цена: результат оплачивается по факту сделанного, что бы ни решилось дальше.

### ПАРАЛЛЕЛЬНО

Оба этапа можно вести параллельно. Фиксированная цена MVP снимает конфликт «гейт не успевает защитить сборку»: даже если тест покажет САС выше порога, оплата MVP отражает реально выполненную работу

Дальше — не часть этого ask, формула по результату: ведение продукта — \$35 000/мес, минимальный срок; рост и продуктовый лид — поверх, с шестого месяца, если гейт пройден.

THRESHOLD

# Гейт после смоук-теста и капитал далее

Гейт после смоук-теста, порог по САС:

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| НИЖЕ \$75  | идём по плану                                                  |
| \$75–150   | идём с планом органики                                         |
| ВЫШЕ \$150 | платный поиск не основной канал, дальнейший найм не начинается |

Капитал по рубежам далее — для ориентира, не часть текущего ask. Базовый сценарий, буфер 15%.

| РУБЕЖ                           | ПРИ САС \$75 | ПРИ САС \$150 |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| MVP живой, САС известен — мес 5 | \$135k       | \$227k        |
| + завершаемость — мес 6         | \$135k       | \$277k        |
| + второй протокол — мес 9       | \$135k       | \$416k        |

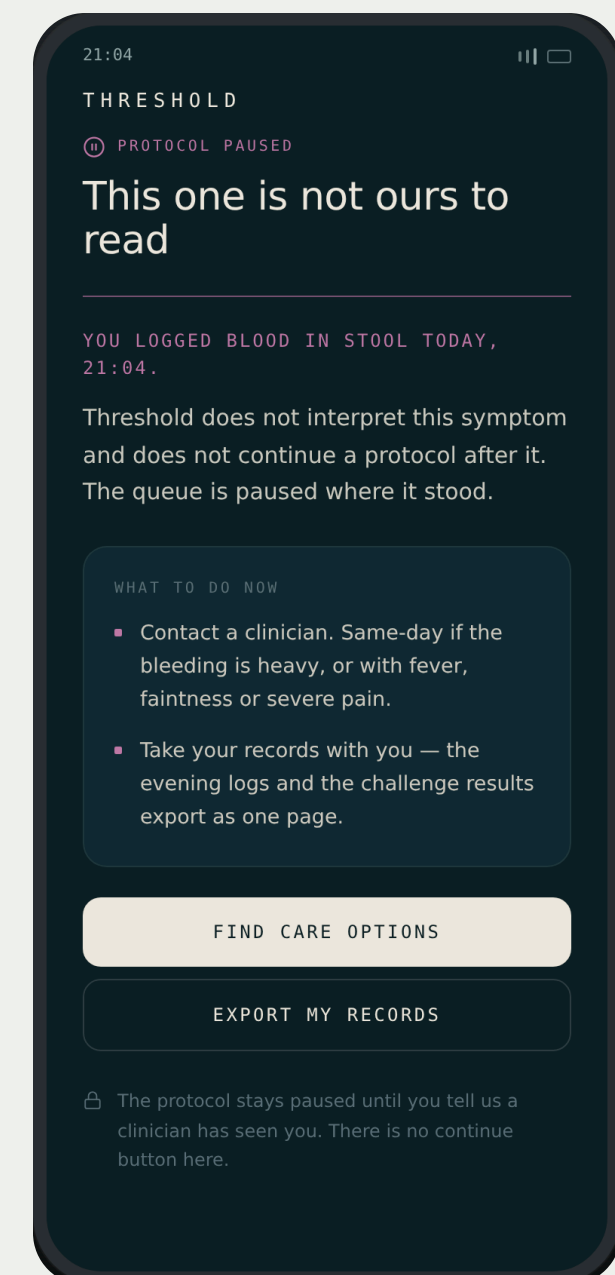
Открытое допущение: стоимость команды после запуска качает капитал далее от \$135k до \$2,5M на горизонте 36 месяцев — известная неопределённость, поэтому не входит в текущий запрос.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Красные флаги и критерии исключения протокола

Протокол останавливается сам и не предлагает обходного пути: кровь в стуле, непреднамеренная потеря веса, симптомы, будящие ночью, дебют после пятидесяти.

Экран не интерпретирует симптом и не ставит диагноз — он останавливает очередь и отправляет к врачу.

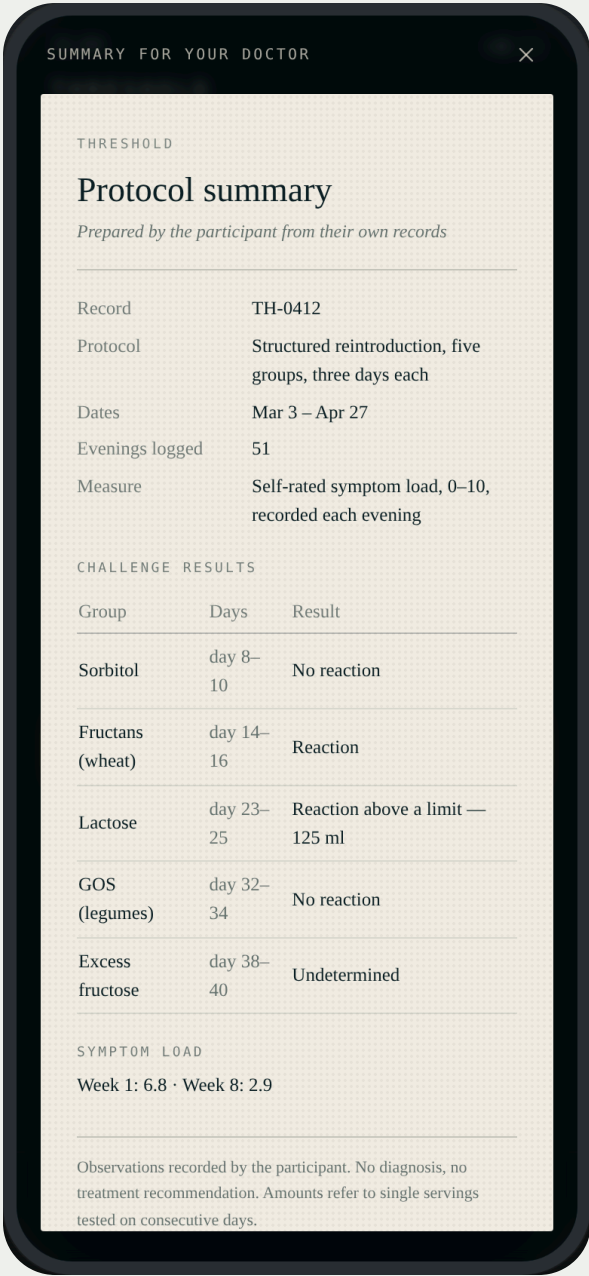




# Экран прототипа с выпиской для врача

Одна страница: протокол, даты, результаты челленджей по группам и динамика симптомов в тех же единицах, что человек отмечал каждый вечер.

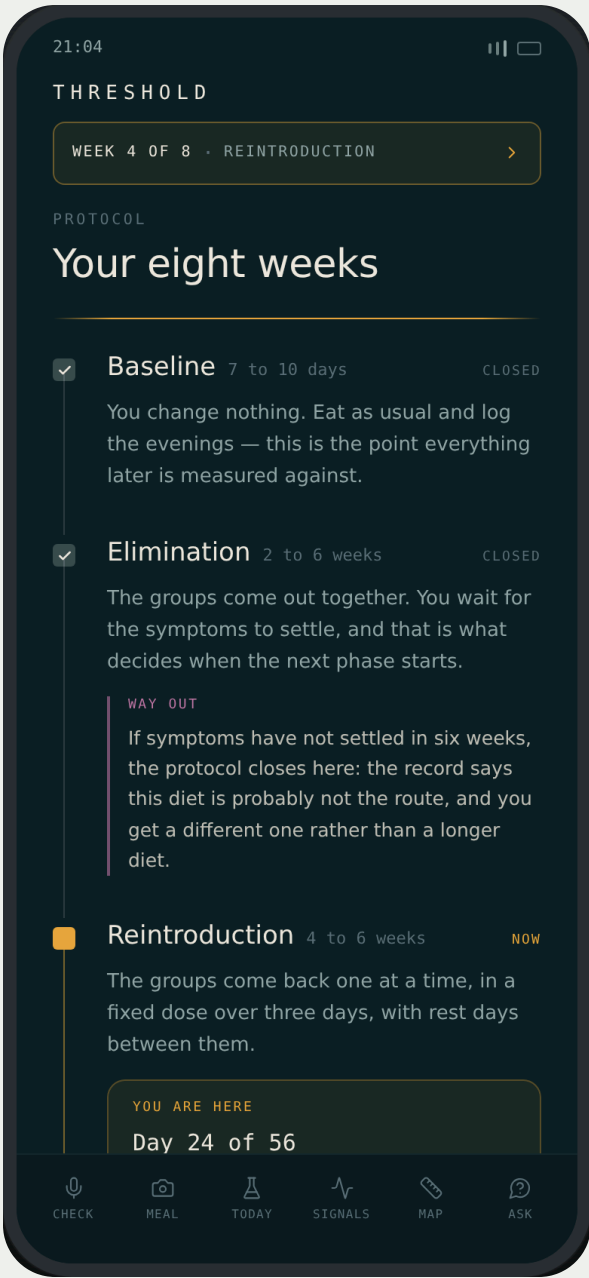
Внизу — строка о том, что это наблюдения участника, а не диагноз и не назначение.



# Экран прототипа: восемь недель протокола

Четыре фазы с границами, текущая позиция днём из пятидесяти шести и правило выхода: если за шесть недель симптомы не осели, протокол закрывается здесь, а не продлевается.

Прогноз дан диапазоном — «4–6 недель», а не датой, потому что переход к следующей фазе решают симптомы, а не календарь.



# Экран прототипа: день челленджа и искажающий фактор

Доза на сегодня, лестница из трёх дней и одна еда на весь челлендж — это и есть ведение, которого нет в дневниках.

Первый день помечен как не засчитанный: четыре часа пятьдесят минут сна накануне, и разделить дозу и ночь по этому дню нельзя. Предложено повторить группу.

